2.**痰培养（确诊金标准）**

痰涂：涂(+):排菌量大有传染性(开放性肺结核)；涂(-):没有传染性

①若**痰培养阳性（菌阳）**——**活动性**肺结核（活性乳酸菌），包括：痰培：菌(+):活动性肺结核；菌(-)

有传染性	痰涂片阳性（**涂阳**）——**开放**性肺结核（**排菌量大**）
无传染性	痰涂片阴性（涂阴）

②**3 次痰涂片+1 次痰培养**均为**阴**性→**菌阴**性肺结核：确诊依靠典型临床表现+典型影像学表现+PPD 强阳性

注意：判断肺结核的活动性　局限、修复的表现

（1）**无活动性（全满足）：无任何症状（无发热等），痰检查不排菌，X 线硬结、钙化、纤维化**

（2）否则为有活动性：①必须抗结核化学治疗，②明确是否有传染性 有活动性不代表有传染性

四、抗结核化学治疗

（一）原则

短程、**早**期、**规**律、**全**程、**适**量、**联**合（多联合 3-4 种药）早恋全是短命鬼

（二）结核杆菌根据代谢状态分为

A 群	最活跃，干酪液化处特别多，极易耐药	**异烟肼**对 **A** 群最敏感（阿姨）
B 群 C 群	处于半静止状态，繁殖速度较慢	**吡嗪酰胺**对 **B** 群最敏感（吡-B） **利福平**对 **C** 群最敏感（Selina）
D 群	完全休眠状态、无致病力、无传染性	无任何药物敏感

（三）抗结核药举例

	主要副作用 （多有肝功损害 尤其异烟肼、利福平、吡嗪酰胺）	
异烟肼 H （H-异）	**周围神经炎（手足麻）**→需加 **VitB$_6$** （烟-炎，麻溜-6）	①能渗入全身各组织，易通过血脑屏障，在干酪性病灶、胸水中药物浓度都很高 ②杀细胞内外 TB（**全杀**）
利福霉素类如利福平 R 和利福喷丁	①若治疗后一过性转氨酶升高：加用保肝药继续用药 肝功能失代偿:黄疸、腹水(黄水) ②ALT 升高 3 倍以上或**黄疸**：**停药**	杀细胞内外 TB（**全杀**）巨噬细胞内外的TB均杀
吡嗪酰胺 Z	**高尿酸**（比内功滋尿）	在细胞**内**杀菌（**半杀**）B群主要存在巨噬细胞内
链霉素 S-锁链	肾毒性、耳毒性 氨基糖苷类抗生素是经典的耳毒性、肾毒性	在细胞外杀菌（**半杀**）
乙胺丁醇 E	**视神经炎**（丁-盯）	**抑菌剂**（乙-E-抑）

吡嗪酰胺、氢氯噻嗪导致高尿酸　呋塞米抑制血管纹的钠钾二氯转运体→降低耳蜗内淋巴电位,降低内淋巴的高钾→感音性耳聋

（四）用药方案

1.活动性肺结核初治　没有链霉素("逊"且肾毒性、耳毒性太大)

①每日用药方案：**2HRZE/4HR（2 个月强化期/4 个月巩固期）**2 个好人择偶变 4 个好人

②间歇用药方案：$2H_3R_3Z_3E_3/4H_3R_3$ 每周3次(隔日1次)　巩固期时用全杀

注意：结节病和结核病的治疗时间都是至少 6 个月